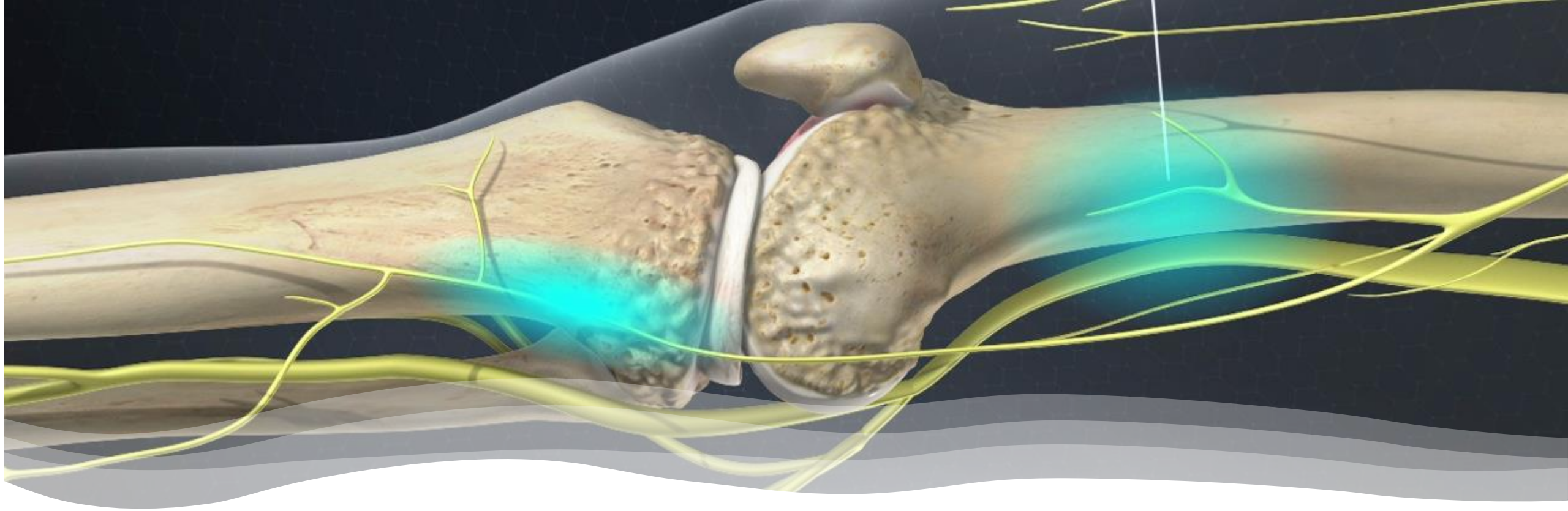
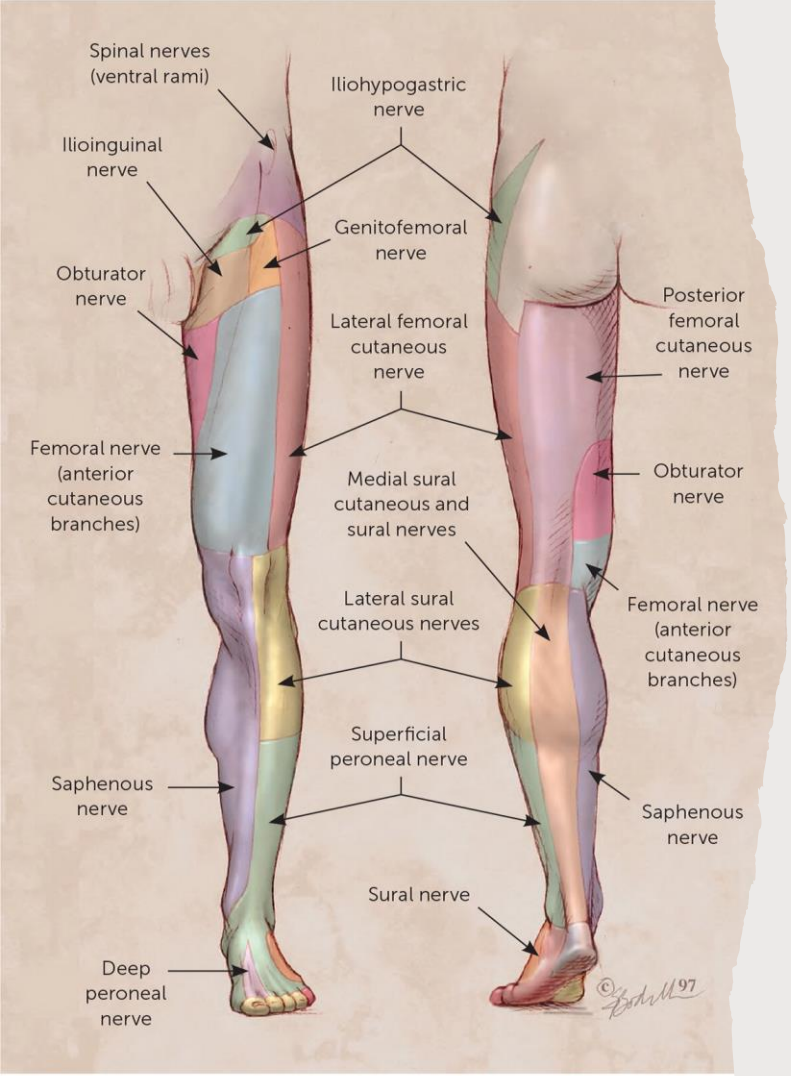
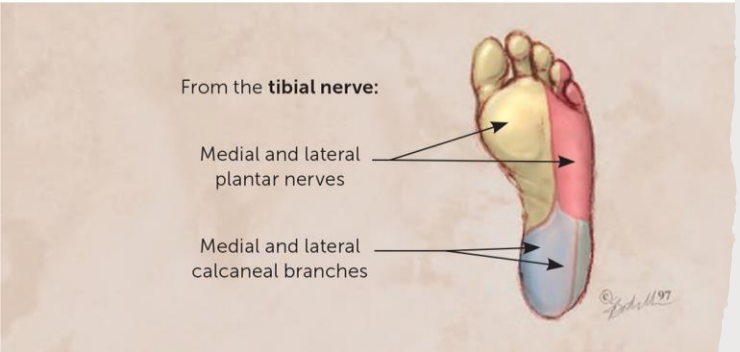


בלוק עצבי פריפרי

Peripheral Nerve Block

בלוק עצבי פריפרי





הזרקת מאלחש מקומי באופן סלקטיבי סביב מבנה עצבי השולח אותות כאב מאזור מסויים בגוף.

שימוש עיקרי במלר"ד- שיכוך כאב סביב טראומה.

שני סוגים:

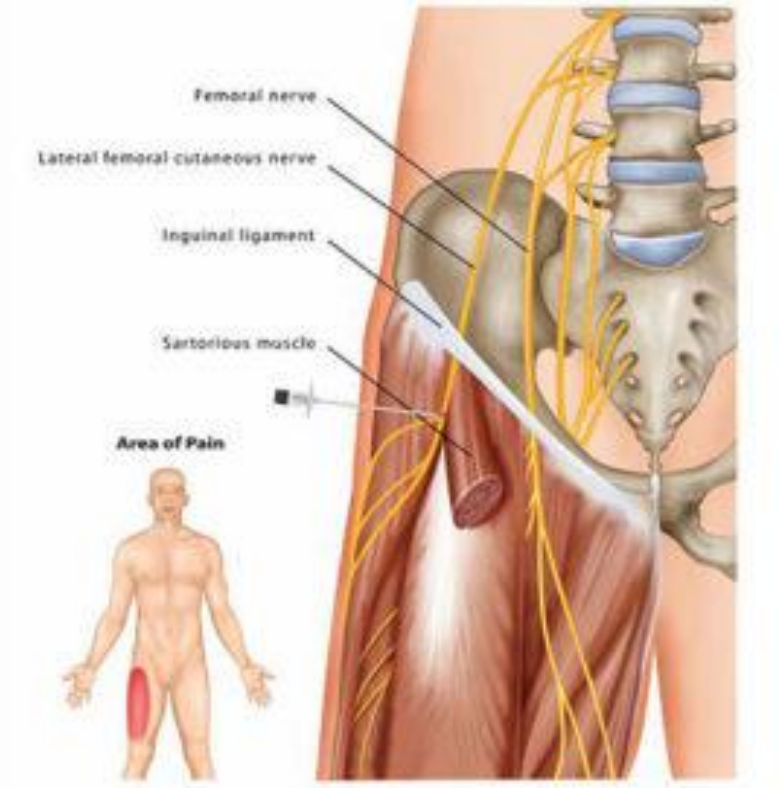
- בלוק חד פעמי (one shot)- הזרקה והוצאת הצנתר.
- מתמשך (continuous)- השארת הצנתר לשיכוך כאב ממושך.

במטופל במלר"ד המיועד לאשפוז ניתן להשאיר בהחלטת רופא צנתר לבלוק מתמשך. אין לחבר את הצנתר להזלפה ממושכת במלר"ד! במקרה כזה יש לסגור את קצה הצנתר לצורך קבלת בלוק מתמשך במחלקה.

ציוד

הפרוצדורה מבוצעת
בטכניקה סטרילית

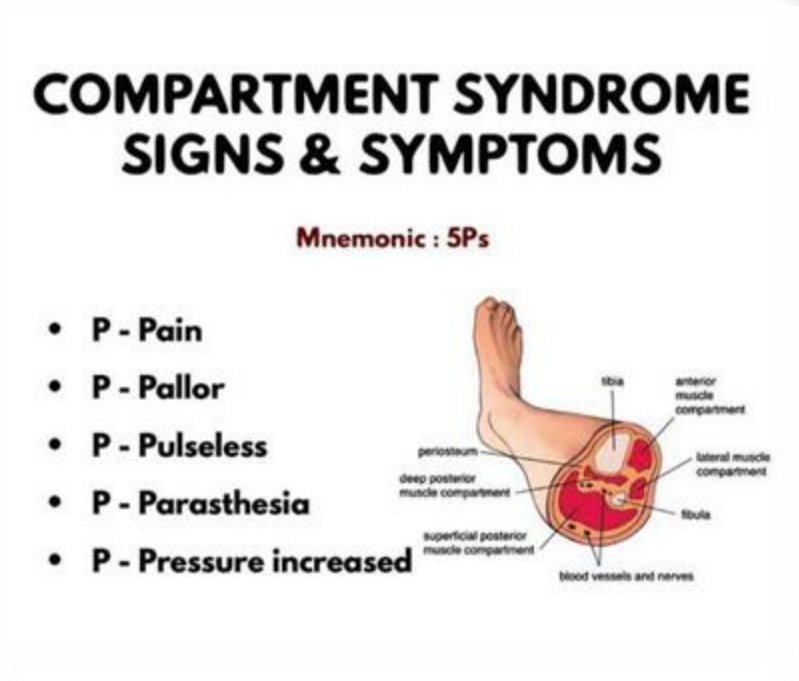
יתרונות



- שיכוך כאב יעיל לטווח ארוך.
- הפחתת מינון משככי כאבים והפחתת צורך בנרקוטיקה.
- הפחתת תופעות לוואי משניות לצריכת נרקוטיקה.
- קיצור משך האשפוז.
- עליה בשביעות רצון המטופל.

סיבוכים

- תגובה אלרגית.
- הזרקה לכלי דם.
- זיהום.
- כאב באזור ההזרקה.
- המטומה באזור ההזרקה.
- פגיעה עצבית (לרוב חולפת).
- בגפה מגובסת- מיסוך תסמונת מדור Compartment Syndrome.
- באזור בית החזה- שיתוק שריר הסרעפת, Pneumothorax.
- בגפיים תחתונות- סיכון לנפילה.



סיבוכים- המשך

Local Anesthetics Systemic Toxicity (LAST)- הרעלת מאלחשים מקומיים

גורמים: הזרקה בשוגג לכלי דם (הנפוץ ביותר), א"ס כליות/ לב/ כבד, ועוד.

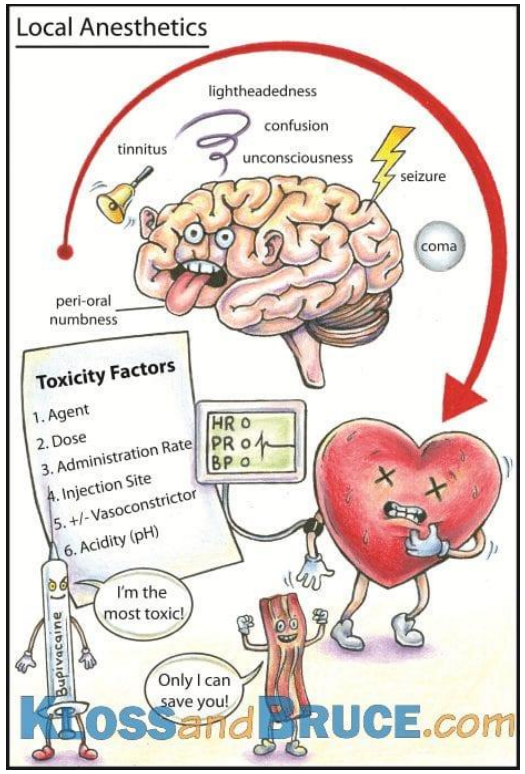
הרעלת CNS:

- נימול סביב השפתיים.
- הפרעות ראיה ושמיעה.
- ירידה ברמת ההכרה.
- פרכוסים.

הרעלה קרדיווסקולרית:

- ירידה בלחץ הדם.
- הפרעות קצב עד אסיסטולה.

הטיפול: טיפול סימפטומטי, מתן Intralipid (נמצא במגירת האנטידוטים במיון שוכבים).



תפקיד האחות

- במטופלים מתאימים- העלאת האפשרות לביצוע בלוק פריפרי בפני הרופא.
- תיעוד- שעת ביצוע הפרוצדורה, אומדן כאב לפני ואחרי הביצוע, תיעוד בטופס הצהוב לידיעת המחלקה.
- ניטור- מעקב אחר תסמיני LAST.
- הערכת אזור הבלוק- מעקב אחר סימני המטומה, זיהום.
- במידה והושאר צנתר קבוע- חבישה יבשה ונקיה.
- אומדן כאב- במידת הצורך שילוב עם אופיואידים לטווח ארוך (כגון Targin) ו- Non Opioids.
- בלוק בגפיים תחתונות- הורדה מהמיטה רק בליווי, לאחר שלילת חסר מוטורי ובמידה והרגל אינה מאולחשת.
- בנוכחות גבס באזור הבלוק- מעקב אחר הופעת סימני Compartment Syndrome.

כאן עבורכם לכל שאלה